

TEMA 3.7 • OBSTETRICIA

Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo

PERFIL EUNACOM 2.01.2.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo

Complicaciones Fetales / Neonatales

DMG y DMPG (ambas)

TABLA 3.7.1: COMPLICACIÓN VS DETALLE

COMPLICACIÓN	DETALLE
Macrosomía	Peso fetal > 4.500 g → indicación de cesárea
Hipoglicemia neonatal	Más frecuente e importante. Control glicemia a las 2 horas de vida (nadir glicémico)
Hipocalcemia neonatal	Puede simular hipoglicemia — medir calcio si hemoglucotest normal con síntomas
Poliglobulia neonatal	Insulina fetal actúa como factor de crecimiento eritroide → puede agravar hipoglicemia
Polihidramnios	Hiperglicemia fetal → glucosuria → poliuria fetal
Distocia de hombros	Mayor riesgo que en hijos de no-diabéticas al mismo peso
Membrana hialina (EMH)	> 34 semanas: pensar en hijo de madre diabética. < 34 sem: riesgo aún mayor

DMPG (adicional)

TABLA 3.7.2: COMPLICACIÓN ADICIONAL VS DETALLE

COMPLICACIÓN ADICIONAL	DETALLE
Malformaciones congénitas	Defectos del tubo neural (anencefalia, espina bífida, meningocele), cardiopatías
Insuficiencia placentaria	→ RCIU, preeclampsia, oligoamnios

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Hipocalcemia que simula hipoglicemia: RN hijo de madre diabética con síntomas de hipoglicemia pero hemoglucotest normal → medir calcio sérico.

Ácido Fólico en Diabéticas

TABLA 3.7.3: PACIENTE VS DOSIS

PACIENTE	DOSIS
Embarazada sin factores de riesgo	0,4 mg/día
Embarazada diabética	4 mg/día (10× la dosis habitual) — prevención malformaciones tubo neural

Interrupción del Embarazo

TABLA 3.7.4: TIPO VS MOMENTO DE INTERRUPCIÓN

TIPO	MOMENTO DE INTERRUPCIÓN
DMG bien controlada	39–41 semanas (se ofrece desde 39 sem)
DMPG	Igual, con tendencia a interrumpir antes si hay complicaciones

Vía de parto: - **Vaginal** como regla general (diabetes no contraindica parto vaginal) - **Cesárea electiva** si peso fetal ≥ 4.500 g (DMG) o ≥ 4.000–4.500 g (DMPG, según contexto)

Control Postparto

- **TTGO a las 6–12 semanas** postparto (cuando termine el puerperio)
- Objetivo: descartar diabetes mellitus tipo 2 subyacente
- La DMG es un marcador de riesgo de DM2 futura

NOTA CLÍNICA

La DMG es causada por resistencia insulínica inducida por lactógeno placentario (hormona de contraregulación). La resistencia residual puede persistir como DM2 en el postparto.

Resumen de Manejo

TABLA 3.7.5: MOMENTO VS ACCIÓN CLAVE

MOMENTO	ACCIÓN CLAVE
Preconcepcional (DMPG)	Optimizar control, HbA1c < 7%, insulina, ácido fólico 4 mg/día
Embarazo	Glicemias preprandial < 90 / postprandial < 120, insulina NPH
Parto	Hemoglucotest frecuente, insulina cristalina si necesario
RN hijo de diabética	Glicemia a las 2 horas + calcio si síntomas con glicemia normal

| Postparto materno | TTGO 6–12 semanas |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo: Embarazo ## Complicaciones Fetales / Neonatales ### DMG y DMPG (ambas) | Comp... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Complicaciones Fetales / Neonatales
- DMG y DMPG (ambas)
- DMPG (adicional)
- Ácido Fólico en Diabéticas
- Interrupción del Embarazo
- Control Postparto
- | Peso fetal > 4.500 g → indicación de cesárea | |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CONTROL OBSTÉTRICO DE LA DIABETES EN EL EMBARAZO)**PREGUNTA 1**

En relación a Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo: Embarazo ## Complicaciones Fetales / Neonatales ### DMG y DMPG (ambas) | Comp... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Control Obstétrico de la Diabetes en el Embarazo. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: CONTROL OBSTÉTRICO DE LA DIABETES EN EL EMBARAZO

:::tip Hipocalcemia que simula hipoglicemia: RN hijo de madre diabética con síntomas de hipoglicemia pero hemoglucotest normal → medir calcio sérico. ::::note La DMG es causada por resistencia insulínica inducida por lactógeno placentario (hormona de contraregulación). La resistencia residual puede persistir como DM2 en el postparto. :::